Лекар, пациент, екип и закон

Хронично болният пациент, модели на взаимоотношение, междупрофесионални отношения и правна отговорност на лекаря

Упражнение 4 · CMME — I част · 2026/2027

гл. ас. д-р Костадин Костадинов, д.м.

Катедра „Социална медицина и обществено здраве“

Четири въпроса за днешното упражнение

1. Хронично болният пациент
2. Модели на взаимоотношението лекар – пациент
3. Междупрофесионални отношения
4. Правна отговорност на лекаря

Хронично болният пациент

Хроничната болест променя логиката на грижата

Измерение	Остра грижа	Хронична грижа
Време	Ограничен лечебен епизод	Продължително или пожизнено проследяване
Цел	Овладяване на опасността, възстановяване	Контрол, запазени функции, приемливо качество на живот
Пациент	Получава помощ, изпълнява краткосрочен план	Взема ежедневни решения, извършва голяма част от грижите
Лекар	Диагностицира и действа своевременно	Поддържа отношението, договаря цели, координира

Болест е диагнозата; **боледуване** е преживяването ѝ. Добрата грижа обхваща и двете.

Механизми на справяне с болестта

Насочени към проблема

Търсене на информация, самонаблюдение, промяна на режима, планиране, търсене на помощ.

Насочени към емоцията

Дистанциране, отричане, отвличане на вниманието, споделяне, религиозна опора.

Насочени към смисъла

Преподреждане на целите, нови роли, ценности отвъд болестта.

Диагнозата разделя живота на „преди“ и „след“. Задачата на лекаря е да подкрепи приспособяването, а не да оценява „правилната“ реакция.

Чести реакции и отговор на лекаря

Реакция	Как изглежда	Професионален отговор
Отричане	„При мен не е толкова сериозно.“	Постепенна информация; проверка на опасните пропуски
Гняв	Обвинения към екипа и близките	Назоваване на емоцията, без лично засягане
Регресия	Пасивност, пълна зависимост от другите	Запазване на уменията, малки договорени задачи
Безнадеждност	„Няма смисъл да се лекувам.“	Оценка за болка, депресия, риск от самонараняване

Реакциите се повтарят при всяко ново усложнение и не са морален дефект.

Автономност, придържане и терапевтичен товар

Релационна автономност

Зависимостта от апарат, лекарства или близки не отнема правото на избор. Изборът обаче може да е повлиян от вина, страх или натиск.

Придържане, не послушание

Непридържането може да е неволно или съзнателно. Първо се търси причината, а не виновният.

Терапевтичен товар

Лекарства, измервания, прегледи, пътуване, разходи. Колко още може да понесе този човек?

Споделена отговорност

Лекарят — за обоснован и разбираем план; пациентът — за честна обратна връзка; системата — за достъпна грижа.

Семейството: подкрепа, товар и граници

Какво носи семейството

- Ежедневна грижа и наблюдение.
- Познание за живота на пациента.
- Емоционална и практическа опора.

Какви са рисковете

- Говорят вместо пациента.
- Свръхзакрила, загуба на умения.
- Изтощение на основния грижещ се.
- Пренебрегване или насилие.

Пациентът определя кои близки участват и какво узнават.

Казус 1 · Докторът ми е стар приятел

> Пациент с новооткрита артериална хипертония се познава с лекаря си от детството. Два месеца след началото на лечението налягането е по-високо. Пациентът пие лекарството само когато сам прецени и през смях казва: „Знаем се от години — просто ми предпиши по-силни хапчета.“

- Какво обяснява поведението му: недисциплинираност или модел на болестта?
- Кой модел на отношение е подходящ?
- Помага или пречи приятелството?

Модели на взаимоотношението лекар – пациент

Четири модела на взаимоотношението лекар – пациент

Модел	Основна характеристика	Водещ риск
Патерналистичен	Лекарят определя най-доброто и води решението	Подмяна на волята на пациента
Автономен	Информираният пациент прави собствен избор	Пациентът остава без достатъчна подкрепа
Бизнес модел	Лекарят предлага услуга, пациентът е потребител	Търговският интерес измества грижата
Договорен модел	Договарят се цели, права, задължения и проследяване	Отношението се свежда до формални условия

Моделът описва отношението и разпределението на ролите.

Патерналистичен и автономен модел

Патерналистичен

Лекарят определя какво е добро за пациента и води решението.

Граница: способният и информиран пациент запазва правото си на избор и отказ.

Пример: лекарят избира лечение, без да обсъди предпочитанията на пациента.

Автономен

Пациентът избира след разбираема информация за възможностите, ползите и рисковете.

Граница: изборът изисква подкрепа; лекарят дава обоснована препоръка.

Пример: пациент избира между две допустими операции според важните за него последици.

Бизнес модел и договорен модел

Бизнес модел

Лекарят е доставчик, пациентът — потребител. Значение имат изборът, цената и качеството на услугата.

Риск: ненужни услуги или предпочитане на печалбата пред медицинската потребност.

Договорен модел

Лекарят и пациентът договарят цели, права, задължения и проследяване.

Пример: при диабет уточняват лечение, самонаблюдение, контролни прегледи и кога планът се променя.

Договореният план разпределя задачите и запазва професионалната отговорност на лекаря.

Патернализъм и професионална граница

Силен патернализъм

Ограничава способен и информиран пациент. Скриване на диагноза, пренебрегнат отказ: не се оправдава.

Слаб патернализъм

Защитава човек с нарушена способност за конкретното решение; трае, докато основанието съществува.

- Пациентът може да откаже предложеното лечение, но не може да изиска вредно или ненужно.
- Лекарят може да откаже лечение при липса на доверие, но никога спешна помощ (Кодекс, чл. 11, 12).

Споделено вземане на решения

1	2	3	4	5
Има избор	**Разумни възможности**	**Какво е важно за пациента**	**Препоръка с основания**	**План и проверка**

- Закон за здравето, чл. 86, ал. 1: право на ясна информация на достъпен език и на повече от едно медицинско становище.
- Закон за здравето, чл. 190, ал. 1: свобода на действия и решения според квалификацията, стандартите и медицинската етика.

Препоръка без отнемане на избора.

Междупрофесионални отношения

Колегиалност по Кодекса за професионална етика

Член	Съдържание
чл. 40	Колегиалността е основен дълг, който се спазва, като се уважават интересите на болния.
чл. 41	Морална помощ; забрана за клевета и злословене; разногласията не са предмет на публични полемики.
чл. 42	Недостойно е колега да бъде злепоставян чрез критика на лечението или на личността му.
чл. 46	Етичните спорове между лекари се решават от комисиите по професионална етика на БЛС.
чл. 49	Лекарят помага на заболял колега и сътрудничи с лекуващите го.

Консултация, консилиум и приемственост

Консултация

Търси се, когато състоянието го налага (чл. 35). Консултантът съобщава заключението на лекуващия и на пациента (чл. 36, ал. 2; чл. 45).

Консилиум

При трудности в диагнозата и лечението; решението при общо съгласие обвързва екипа (чл. 38, ал. 2), но не заменя съгласието на пациента.

Приемственост

Пълна информация при оттегляне (чл. 24); промяна в отсъствие на лекуващия се документира (чл. 50).

Пропуските при предаване на пациента са честа причина за предотвратима вреда.

Лекар, медицинска сестра и екип

Различни роли, общ пациент

Всяка професия има собствена компетентност, съсловна организация и етичен кодекс.

Ясни назначения

Писмени, четливи, проверими. Съмнението се изяснява, не се изпълнява мълчаливо.

Право на глас

Всеки член на екипа може да спре процедура при риск за безопасността.

Уважение

Публичното унижаване пред пациенти разрушава доверието и прикрива грешките.

Колегиалност не означава прикриване

Положение	Риск	Професионално поведение
Колега търси помощ	Непълен преглед без документация	Формална консултация и проследяване
Колега научава диагнозата	Разпространяване от любопитство	Същата поверителност като за всеки пациент
Болестта засяга работата	Прикриване или автоматично отстраняване	Индивидуална оценка, пропорционално ограничаване
Непосредствен риск	Отлагане в името на колегиалността	Защита на пациентите и помощ за лекаря

Казус 2 · Хирургът с тремор

Опитен хирург забелязва фин тремор на ръката и моли приятел невролог да го прегледа неофициално след работа. Прегледът поражда съмнение за прогресиращо заболяване. Хирургът отказва документиране и допълнителни изследвания. На следващия ден има сложна планова операция.

- Какъв е статутът на неформалния преглед?
- Как се съчетават тайната, колегиалността и безопасността на пациентите?
- Какво трябва да направи невроложът?

Правна отговорност на лекаря

Четири вида правна отговорност

1. Дисциплинарна

КТ: дисциплинарни наказания; имуществена отговорност към работодателя.

2. Административна

ЗАНН: нарушения и глоби; подвид: **съсловна** пред БЛС / БЗС.

3. Наказателна

НК: лична отговорност за престъпление; наказва съдът.

4. Гражданска

ЗЗД: обезщетение за вреди; **договорна** и **деликтна / извъндоговорна**.

В първия блок двата режима по КТ са разгледани заедно; имуществената отговорност има самостоятелно основание (чл. 203, ал. 3). Видовете се съчетават при условията на всеки режим: при наказателно преследване за същото деяние административнонаказателно производство не се образува (ЗАНН, чл. 33, ал. 1).

1. Дисциплинарна отговорност

Дисциплинарни наказания

Основание: КТ, чл. 186–188 — виновно нарушение на трудовите задължения.

Забележка, предупреждение за уволнение, дисциплинарно уволнение.

Кой: работодателят или оправомощено лице (чл. 192), след обяснения (чл. 193).

Имуществена отговорност

Основание: КТ, чл. 203 и сл. — вреда за работодателя; при небрежност важат пределите на чл. 206.

Кой: работодателят със заповед; при оспорване — съдът (чл. 210). Пълната отговорност е по съдебен ред (чл. 211).

Пример: лекар закъснява за дежурство; при отделно доказана вреда за болницата може да дължи и обезщетение.

2. Административна отговорност

Нарушения и глоби

Основание: ЗАНН, чл. 6, 13, 47; Закон за здравето, чл. 221, 229.

Кой: за чл. 221 — ИА „Медицински надзор“ (чл. 233а); за чл. 229 — РЗИ или ИА „Медицински надзор“ (чл. 235).

Пример: лечебно заведение нарушава законово право на пациент.

Подвид: съсловна · БЛС / БЗС

Основание: ЗСОЛЛДМ, чл. 37–41; етичният кодекс. Порицание, глоба, временно заличаване от регистъра.

Кой: председателят на УС на районната колегия (чл. 40, ал. 3), след акт от член на етичната комисия.

Пример: лекар злепоставя колега пред пациенти.

3. Наказателна отговорност

Основание · Наказателен кодекс

Чл. 11: умисъл или непредпазливост; последната е наказуема в предвидените от закона случаи.

Чл. 123 и 134: смърт или тежка / средна телесна повреда при незнание или немарливо изпълнение на опасно занятие.

Кой налага наказанието

Съдът установява вината и налага наказанието. Прокуратурата повдига и поддържа обвинението по дела от общ характер.

Доказват се деянието, причинната връзка с вредата и вината.

Пример: немарливо приложена погрешна доза причинява смърт. Чл. 123 е приложим, ако са доказани всички признаци на състава.

4. Гражданска отговорност

Договорна · ЗЗД, чл. 79–82

Неточно изпълнение на договорно задължение; обезщетение за преките, непосредствени и предвидими при пораждане на задължението вреди (чл. 82).

Пример: договорено изследване не е извършено и пациентът понася доказани допълнителни разходи.

Деликтна / извъндоговорна

ЗЗД, чл. 45: виновно причинена вреда; вината се предполага, а вредата и причинната връзка се доказват.

Чл. 49: отговорност на лечебното заведение като възложител.

Пример: погрешна инжекция увреждa нерв на пациента.

Съдът присъжда обезщетение по иск на увредения. Договорът и деликтът са два подвида на гражданската отговорност.

Казус 3 · Предаване без новия симптом

В края на дежурството си на 24 декември лекар чака закъсняващия колега почти час. Медицинска сестра съобщава за гръдна болка у пациент с пневмония. Лекарят назначава ЕКГ, но при бързото предаване забравя да спомене симптома. По-късно пациентът умира от остър миокарден инфаркт.

- Приложете четирите вида отговорност: кои могат да възникнат и за кого?
- Какво трябва да се докаже за гражданската и за наказателната отговорност?
- Какъв е делът на организацията?

Доверието се гради в отношението, в екипа и в институцията.

Законът очертава последиците, когато то бъде нарушено.